HER HAFTA BİR VAKA™ · BONUS 3

Meslektaşlara Vaka Sunumu Şablonları

Bir vakayı 60 saniyede, 5 dakikada ya da bir posterde düzenli anlatmak için hazır yapılar, köşeli parantezli şablonlar ve kayıt kontrol listesi.

İçindekiler

Sunumdan önce: dört kural

60 saniyelik sunum

5 dakikalık sunum

Poster sunumu

Meslektaşa yazılı görüş sorma

Kayıt kontrol listesi: fotoğraflar, modeller, radyografiler

Önce / sonra karşılaştırması

Sık sunum hataları

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Sunumdan önce: dört kural

Hangi formatta olursa olsun aynı omurga.

1. **Tek soru belirleyin.** "Bu vakada sizden ne istiyorum?" Görüş mü, karar mı, öğretim mi? Sunumun ilk ve son cümlesi bu soruya bağlanır.
2. **Aynı sırayı kullanın.** Kimlik ve şikâyet → bulgular → problem listesi → plan → soru veya sonuç.
3. **Hastayı anonimleştirin.** Ad, dosya numarası ve tarih gibi tanımlayıcıları çıkarın. Yüz fotoğrafları için kliniğinizin kullandığı onam formuna bakın.
4. **Kayıtlar standart olsun.** Aynı açı, aynı ışık, aynı sıra. Kayıt kontrol listesini sunumdan önce işaretleyin.

FORMAT	NE ZAMAN	ANA HEDEF
60 saniye	Klinik içi kısa danışma, koridor görüşmesi	Tek bir karar için görüş almak
5 dakika	Vaka toplantısı, çalışma grubu	Planı tartışmak veya tamamlanmış vakayı anlatmak
Poster	Kongre ve bilimsel etkinlikler	Vakayı tek bakışta anlaşılır kılmak

FORMAT 1

60 saniyelik sunum

Dört blok, her biri bir iki cümle.

SÜRE	BLOK	İÇERİK
0–10 sn	Kimlik ve şikâyet	Yaş, cinsiyet, büyüme durumu, hastanın kendi cümlesiyle şikâyeti.
10–30 sn	Ana bulgular	Molar/kanin ilişkisi, overjet/overbite, çapraşıklık, iki üç sefalometrik değer, önemli bir öykü.
30–45 sn	Problem ve seçenekler	En önemli problem ve düşündüğünüz iki seçenek.
45–60 sn	Soru	Meslektaşınızdan tam olarak ne istediğiniz.

Şablon

[Yaş] yaşında, **[büyüme durumu]** bir **[kız / erkek / kadın / erkek hasta]**. Şikâyeti: "**[hastanın cümlesi]**".

Molar ilişki **[sağ / sol]**, overjet **[mm]**, overbite **[mm]**. Üstte **[mm]**, altta **[mm]** çapraşıklık. ANB **[°]**, FMA **[°]**. Önemli öykü: **[alışkanlık / travma / genel sağlık]**.

Bence ana problem **[problem]**. İki seçenek düşünüyorum: **[seçenek 1]** veya **[seçenek 2]**.

Sizden şunu sormak istiyorum: **[tek, net soru]**?

Doldurulmuş örnek (kurgusal)

13 yaşında, büyüme atılımına yakın bir erkek hasta. Şikâyeti: "Dişlerim önde."

Molar ilişki iki tarafta Sınıf II tam birim, overjet 8 mm, overbite 5 mm. Üstte 4 mm, altta 3 mm çapraşıklık. ANB 6°, FMA 25°. Bir yıl önce üst santralde kron kırığı öyküsü var.

Bence ana problem mandibular retrüzyona bağlı Sınıf II ve artmış overjet. İki seçenek düşünüyorum: fonksiyonel aparey ile başlamak veya büyüme bitince çekimli kamuflaj.

Sizden şunu sormak istiyorum: Travma öyküsü olan bu hastada fonksiyonel apareye şimdi mi başlardınız?

FORMAT 2

5 dakikalık sunum

10 slayt, toplam yaklaşık 5 dakika. Her slaytta tek fikir.

SLAYT	SÜRE	BAŞLIK	İÇERİK
1	30 sn	Başlık ve soru	Vaka başlığı ve sunumun tek sorusu veya ana mesajı.
2	30 sn	Kimlik ve şikâyet	Yaş, büyüme durumu, şikâyet, ilgili öykü.
3	40 sn	Ekstraoral fotoğraflar	Önden dinlenme, önden gülüş, profil. Bir cümleyle profil yorumu.
4	40 sn	İntraoral fotoğraflar	Önden, sağ, sol, üst ve alt oklüzal. Kapanış bulgularını sırayla.
5	30 sn	Radyografiler	Panoramik bulgular (Araç 1 sırasıyla) ve lateral sefalometri.
6	30 sn	Sefalometrik özet	Sekiz ölçüm ve üç cümlelik yorum: sagital, vertikal, dental.
7	30 sn	Problem listesi	Sagital, vertikal, transversal, yer ve hastanın şikâyeti.
8	30 sn	Hedefler ve plan	Hedefler, seçenekler ve seçilen plan; gerekçe.
9	20 sn	Süreç veya sonuç	Devam eden vakada mevcut aşama; biten vakada önce/sonra.
10	20 sn	Soru veya öğrenilen	Tartışma sorusu veya bu vakadan çıkan bir ders.

Problem listesi slaytı · şablon

Sagital: [molar/kanin ilişkisi, overjet, iskeletsel kaynak]

Vertikal: [overbite, vertikal patern]

Transversal: [çapraz kapanış, orta hatlar]

Yer: [üst ve alt çapraşıklık/boşluk, mm]

Hastanın şikâyeti: [hastanın cümlesi]

Plan slaytı · şablon

Hedefler: 1) [hedef] 2) [hedef] 3) [hedef]

Seçenekler: A) [seçenek] · B) [seçenek]

Seçilen plan ve gerekçe: [plan], çünkü [gerekçe].

Ankraj ve pekiştirme: [ankraj planı] · [pekiştirme planı]

FORMAT 3

Poster sunumu

Bir metre uzaktan okunacak kadar az metin, tek bakışta anlaşılacak kadar düzen.

Başlık
[Vakayı tek cümleyle anlatan başlık] · [Kurum veya klinik adı, etkinliğin istediği biçimde]

Giriş
[Vakanın neden ilginç olduğu, 2–3 cümle]

Vaka bilgileri
[Yaş, şikâyet, öykü; ekstraoral ve intraoral fotoğraflar]

Teşhis
[Sefalometrik özet tablosu ve problem listesi]

Plan
[Hedefler, seçenekler ve seçilen plan]

Tedavi süreci
[Aşamalar ve süre; ara fotoğraflar]

Sonuç
[Önce / sonra fotoğrafları, son sefalometri karşılaştırması]

Tartışma ve öğrenilenler
[Bu vakadan çıkan 2–3 ders; kısa ve somut]

Poster kontrol listesi

- [ ] Etkinliğin boyut ve biçim kurallarını okudum.
- [ ] Her bölüm en fazla birkaç kısa cümle.
- [ ] Fotoğraflar aynı açı ve ışıkta, önce/sonra yan yana.
- [ ] Sefalometrik değerler tabloda, metinde tekrar edilmiyor.
- [ ] Hasta tanımlayıcıları çıkarıldı; onam kliniğinizin kullandığı onam formuyla alındı.
- [ ] Başlık uzaktan okunuyor.

ŞABLON

Meslektaşa yazılı görüş sorma

Kısa, düzenli ve tek soruya odaklı bir mesaj daha hızlı ve daha net cevap alır.

Ortodontist meslektaşa

[Meslektaşın adı] Hocam merhaba,

Bir vaka hakkında kısa bir görüşünüzü rica ediyorum. **[Yaş]** yaşında **[büyüme durumu]** bir hasta. Ana bulgular: **[molar ilişki, overjet, overbite, çapraşıklık]**; ANB **[°]**, FMA **[°]**.

İki seçenek arasında kaldım: **[seçenek 1]** ve **[seçenek 2]**. Benim eğilimim **[seçenek]**, çünkü **[gerekçe]**.

Sorum: **[tek soru]**? Kayıtlar anonimleştirilmiş olarak ektedir.

Teşekkürler, **[Adınız]** · **[Klinik adı]**

Cerrah, periodontolog veya protez hekimine konsültasyon notu

Hasta: **[dosya kodu]**, **[yaş]** · **Konsültasyon nedeni:** **[ör. cerrahi seçenek değerlendirmesi / periodontal stabilite onayı / implant yeri planı]**

Ortodontik bulgular: **[kısa özet]**

Ortodontik plan: **[planlanan diş hareketleri ve tahmini aşamalar]**

Sizden beklenen: **[net soru veya onay]**

Ekler: **[fotoğraflar, radyografiler, sefalometrik özet]**

KONTROL LİSTESİ

Kayıt kontrol listesi

Her başlangıç, ara ve bitiş kaydında aynı liste. Sunumdan önce eksikleri tamamlayın.

Ekstraoral fotoğraflar

- [ ] Önden, dinlenmede
- [ ] Önden, gülüşte
- [ ] Profil, dinlenmede
- [ ] Üç çeyrek açıdan gülüş
- [ ] Gerekirse aşağıdan (asimetri için)

İntraoral fotoğraflar

- [ ] Önden, kapanışta
- [ ] Sağ bukkal
- [ ] Sol bukkal
- [ ] Üst oklüzal
- [ ] Alt oklüzal
- [ ] Overjet görünümü (yandan)

Modeller

- [ ] Üst ve alt arkın tam kaydı (dijital veya alçı)
- [ ] Kapanış kaydı
- [ ] Gerekirse sentrik ilişki kaydı
- [ ] Yer analizi ve Bolton sonuçları

Radyografiler

- [ ] Panoramik (Araç 1 sırasıyla okunmuş)
- [ ] Lateral sefalometri ve trazlama
- [ ] Endikasyona göre ek görüntüleme
- [ ] Ara ve bitiş radyografileri

Fotoğraf standardı

- [ ] Aynı arka plan ve ışık; yansıma yok.
- [ ] Baş doğal pozisyonda, profil fotoğrafında Frankfort düzlemi yere yaklaşık paralel.
- [ ] İntraoral fotoğraflarda ekartör ve ayna kullanımı her kayıtta aynı.
- [ ] Dosya adlarında hasta adı yok; kliniğinizin dosya kodu ve kayıt aşaması (başlangıç / ara / bitiş).

SONUÇ SUNUMU

Önce / sonra karşılaştırması

Değişimi dürüst göstermek için aynı koşullar.

KURAL	NEDEN
Aynı açı ve aynı büyütme	Farklı açı değişimi abartabilir veya gizleyebilir.
Aynı ışık ve arka plan	Renk ve kontrast farkı değişim gibi algılanır.
Yan yana veya üst üste	İzleyici karşılaştırmayı kendi yapabilmeli.
Sefalometrik değerleri tabloda verin	Başlangıç, bitiş ve fark üç sütunda.
Sınırlılıkları söyleyin	Elde edilemeyen hedefleri de yazmak sunumu güvenilir kılar.

Sefalometrik karşılaştırma tablosu · şablon

ÖLÇÜM	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	FARK
SNA			
SNB			
ANB			
Wits			
FMA			
SN-GoMe			
IMPA			
U1-SN			

KAÇININ

Sık sunum hataları

Her biri için tek cümlelik düzeltme.

HATA	DÜZELTME
Soruyu en sona saklamak	Soruyu ilk cümlede söyleyin, son cümlede tekrarlayın.
Bütün sefalometrik değerleri okumak	Sekiz ölçüm tabloda, sözlü olarak yalnızca üç cümlelik yorum.
Problem listesini atlayıp apareyle başlamak	Önce problem listesi ve hedefler, sonra mekanik.
Farklı açı ve ışıkta önce/sonra fotoğrafları	Kayıt kontrol listesini başlangıçta uygulayın.
Hasta tanımlayıcılarını slaytta bırakmak	Dosya adları dahil her şeyi sunumdan önce kontrol edin.
Yalnızca başarılı vakaları sunmak	Takılan bir vakayı sunmak çoğu zaman daha öğreticidir.
Süreyi aşmak	Bir kez yüksek sesle, kronometreyle prova edin.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Bu hafta bir vaka seçin ve 60 saniyelik şablonu doldurun. 52 Haftalık Vaka Çalışma Programı'ndaki **Hafta 49–52** vakaları sunum alıştırması için idealdir.

Sefalometrik özet slaytı için **Sefalometrik Ölçüm Alıştırma Defteri**'ndeki üç cümlelik yöntemi kullanın. Problem listesi ve plan için Başucu Kitabı'nın **Araç 4 · 4 Aşamalı Klinik Planlayıcı**'sını açın.